

REENDODONCIA

En cumplimiento de la Ley 41/2002, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, le presentamos para su firma el siguiente documento:

D./Dña., con documento, como paciente, declaro que el Dr./la Dra., con número de colegiado, me ha diagnosticado:

El paciente es menor de edad. Consigne a continuación el nombre y documento del padre, madre o tutor que presta el consentimiento en su representación.

Nombre y apellidos:

Documento de identidad:

Parentesco o relación con el paciente:

Para dicho diagnóstico me ha propuesto y presupuestado el siguiente plan de tratamiento:

Piezas:

En relación con el diagnóstico, el facultativo me ha explicado, y comprendo, que:

Documento de información al paciente

Sobre reendodoncia

Características del procedimiento: ¿En qué consiste? Consiste en la eliminación de los materiales que se encuentran en el interior de los conductos radiculares de un diente y la posterior limpieza, conformación y relleno de dichos conductos. ¿Para qué sirve? Es una intervención que se realiza cuando una endodoncia no tenido éxito, para intentar conservar el diente en el lugar que ocupa en la arcada dentaria, manteniendo una función adecuada.

- ¿Cómo se hace? Tras anestesiar localmente la zona, se realiza una cavidad para acceder al interior del diente. Luego se eliminan los materiales de relleno utilizados en la endodoncia previa, se limpian los conductos radiculares y se rellenan con un material adecuado. Finalmente se coloca un empaste provisional que deberá ser sustituido por uno definitivo. Será necesario el uso de radiografías dentales intraorales para realizar el procedimiento. Dependiendo del estado - previo del diente y de la anatomía que presente, pueden ser necesarias una o más sesiones

Riesgos y complicaciones: Cualquier intervención en un paciente conlleva riesgos. La mayor parte de las veces no se presentan complicaciones, pero a veces sí, por lo que es importante que estas se conozcan. Las más frecuentes son: A) Referidas al uso de anestésicos locales: Interrupción de la función sensitiva (sensación de hormigueo) generalmente de forma temporal, ulceración en la mucosa, aparición de hematomas y alteraciones generalmente transitorias como bloqueo de la articulación temporomandibular, crisis vaso-vagal consistente en sudoración fría, sensación de mareo, bajada de tensión arterial e incluso lipotimia. En el caso de existir alguna alergia conocida a los anestésicos debe avisar siempre al profesional. Si hubiera alguna alergia desconocida pueden producirse alteraciones del tipo urticaria, edema de glotis e incluso shock anafiláctico, que necesitarían otros medios de reanimación. B) Referidas al tratamiento en sí: Durante la fase de apertura y limpieza de los conductos pueden aparecer alteraciones no detectables que imposibiliten la continuación

del tratamiento de conductos tales como: existencia de una red compleja de curvaturas o calcificaciones imposibles de trabajar con los instrumentos disponibles actualmente, comunicaciones con los tejidos periodontales,

- bien contratiempos como la fractura de algún instrumento que el profesional intentará subsanar, pero que en el caso de no lograrse complicarían el pronóstico del tratamiento

C) Referidas al futuro del tratamiento: Una vez finalizado el tratamiento es necesario realizar la restauración definitiva del diente. Si dicha reconstrucción no fuese la indicada o se retrasase en exceso o el paciente tuviera hábitos de apretamiento (bruxismo) o mordiese accidentalmente alimentos muy duros sobre los dientes desvitalizados, podrían producirse fisuras verticales o fracturas radiculares que empeorarían el pronóstico restaurador, pudiendo llegar a implicar la necesidad de extraer el diente. Una vez terminado el tratamiento (o entre las sesiones) el diente puede quedar sensibilizado a la presión durante un periodo más o menos largo pudiendo necesitar algún analgésico. En algunos casos, puede llegar a producirse la inflamación de los tejidos próximos al diente, pudiendo ser necesaria en tal caso la administración de antibióticos. ... Podrán ser necesarias revisiones y radiografías algún tiempo después de realizar el tratamiento para comprobar su evolución y pronóstico definitivo. Puede producirse algún cambio de coloración externa en la corona o bien necesitar algún otro procedimiento como el retratamiento no quirúrgico o la cirugía periapical, si con el primer tratamiento no se consiguiesen los objetivos, ya que en el organismo humano nunca podemos tener

- a priori la garantía absoluta del éxito

% Riesgos personalizados: - Se hará siempre una historia clínica de las enfermedades que afecten al paciente para comprobar la idoneidad del retratamiento de conductos (reendodoncia). Información de su interés: Usted tiene derecho a conocer el procedimiento dental al que va a ser sometido y los riesgos y complicaciones más frecuentes que pueden ocurrir. En su actual estado clínico, los beneficios derivados de la realización de este tratamiento superan los posibles riesgos. Por este motivo se le indica la conveniencia de que le sea practicado. Si aparecieran complicaciones, el personal médico que le atiende está capacitado y dispone de medios para tratar de resolverlas. Por favor, lea atentamente este documento y consulte con su dentista las dudas que pueda tener. Alternativas al procedimiento: La extracción del diente.

Consentimiento informado — reendodoncia

Para satisfacción de los derechos del paciente, como instrumento favorecedor del correcto uso de los Procedimientos Terapéuticos y Diagnósticos, y en cumplimiento de la Ley General de Sanidad y la ley 41/2002: Que el Dr./Dra. me ha explicado, en términos asequibles, que necesito un retratamiento endodóntico en el/los diente/s: Y ME han Sido expuesto los posibles riesgos generales contenidos en las hojas informativas adjuntas, publicadas por la Asociación Española de Endodoncia (AEDE), permitiéndome realizar todas las observaciones y preguntas para aclarar mis dudas.

- Riesgos personalizados en su caso:
- Consiento en que se tomen fotografías o registren otros tipos de soporte audio y visual, antes, durante y después de la intervención quirúrgica, para facilitar el avance del
- conocimiento científico y la docencia. En todos los casos será resguardada la identidad del paciente

Manifiesto que estoy satisfecho con la información recibida y que comprendo el alcance y los riesgos del tratamiento.

También comprendo que, en cualquier momento y sin necesidad de dar ninguna explicación, puedo revocar el consentimiento que ahora presto.

Y entales condiciones CONSIENTO en que se merealice el retratamiento endodóntico. TTO 740 Mim 0 Firma del paciente: Firma del profesional:

Riesgos personalizados

Asimismo, D./Dña., por sus especiales condiciones particulares, puede presentar riesgos añadidos consistentes en:

Contraindicaciones

He informado al facultativo de mi estado de salud, de las enfermedades que padezco o he padecido, de la medicación que tomo actualmente y de mis alergias conocidas. Comprendo que determinadas condiciones médicas, tratamientos farmacológicos o hábitos pueden

desaconsejar este tratamiento, obligar a modificarlo o empeorar su pronóstico, y que el facultativo me ha explicado si alguna de ellas concurre en mi caso.

Contraindicaciones específicas advertidas en mi caso:

Yo, D./Dña., como paciente, he sido informado/a por el Dr./la Dra., comprendo el alcance y el significado de dicha información, he podido formular cuantas preguntas he considerado oportunas y se me han aclarado todas las dudas, y consiento en someterme al procedimiento clínico descrito en este documento.

También he sido informado/a de la posibilidad de revocar este consentimiento por escrito y en cualquier momento, sin necesidad de expresar el motivo, incluyendo las posibles consecuencias que conlleva el no someterse al tratamiento propuesto, así como los riesgos que de esta decisión pudieran derivarse en relación con mi salud bucodental.

Información sobre protección de datos

Responsable: CLINICA IMPLANTDENT SL, CIF B17962564, con domicilio en Carrer de Santa Eugènia, 2. Finalidad: la prestación de asistencia odontológica y la gestión de su historia clínica. Legitimación: el tratamiento es necesario para fines de medicina preventiva, diagnóstico médico y prestación de asistencia sanitaria (art. 9.2.h del Reglamento (UE) 2016/679), así como para el cumplimiento de las obligaciones legales del centro.

Conservación: su historia clínica se conservará durante los plazos legalmente establecidos, con un mínimo de quince años desde el alta de cada proceso asistencial. Destinatarios: no se ceden datos a terceros salvo obligación legal o cuando resulte necesario para su asistencia. Derechos: puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y portabilidad dirigiéndose a info@dentalimplantdent.com, así como presentar una reclamación ante la Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

En Girona, a

El paciente

El odontoestomatólogo informante

Esta página se ha dejado en blanco intencionadamente.